EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 84225
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-05-09 14:49:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: RODOLFO BUSTOS CARRASCO			RUN	: 9.273.197-9
F.Nac	: 06-06-1965	Edad	: 58 AÑOS, 11 MESES	Género	: Masculino
Dirección	: MATTA CASA 655 SAN CARLOS			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 956317223		
Fecha Ingreso	: 2024-05-05	Fecha Egreso	: 2024-05-09 14:49:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. D07.5-CARCINOMA IN SITU DE LA PROSTATA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

NEUMONIA ATS 3
HEMATOMA PARED ABDOMINAL DRENADO (2° VALSALVA INTENSA POR TOS)
CA PROSTATA EN RADIOTERAPIA
TRASTORNO BIPOLAR
ASMA?
HIPOTIROIDISMO

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. J18.9-NEUMONIA, NO ESPECIFICADA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

APROXIMADAMENTE 1 SEMANA CON CUADRO RESPEIRATORIO CON TOS, EXPECTORACIÓN Y DISNEA, QUE SE ACENTÚA DOS DIAS PREVIO A CONSULTAR SERV. URGENCIA HSC. ADEMAS PRESENTA AUEMNTO DE VOLUMEN SUBITO EN PARED ABDOMINAL.
INGRESA, PALIDO, SUDOROSO CON HIPOTENSIÓN SEGUN RELATA DAU.
PRESENTA PARAMETROS INFLAMATORIOS ELEVADOS .
TAC ABDOMEN MUESTRA MASA EN PARED ABDOMINAL APROX 1000 CC COMPATIBLE CON HEMATOMA.
ADEMÁS NEUMOPATIA AGUDA, QUE SE CONFIRMA CON TAC DE TX
DURANTE LA MAÑANA DEL 05/05 SE REALIZA DRENAJE DE HEMATOMA SIN CONFLICTOS. RESIDENTE UTI DESESTIMA INGRESO A SU UNIDAD
A SU INGRESO SALA MEDICINA TRANQUILO, EUPNEICO, HD ESTABLE PERO CON SIGNOLOGIA BRONQUIAL MODERADA PRESENTE.
INICIO TTO ATB CON CEFRIAXONA, MAS KINE, E INHALOTERAPIA. PRESENTA BUENA EVOLUCION PERO CON REQUERIMIENTO DE O2 BAJO FLUJO HASTA AYER EN LA MAÑANA. EX PARAMETROS INFLAMATORIOS A LA BAJA.
POR PARTE DE CIRUGIA SE RETIRA DRENAJE TUBULAR POR DRENAJE DE HEMATOMA AYER Y SE DA DE ALTA (CON INDIC DE CURACIONES EN APS Y RETIRO DE PUNTOS A LOS 10 DIAS POST DRENAJE)
HOY COMPLETA 24 HRS SIN REQUERIMIENTO DE O2, AFEBRIL, ASINTOMATICO, HDN ESTABLE, PERO AUN CON SIGNOLOGIA RESPIRATORIA (ESTERTORES Y SIBILANCIAS BILATERALES), POR LO QUE SE DECIDE HODOM.

PLAN DE MANEJO:

COMPLETAR TTO ATB EN HODOM 3 DIAS MAS, CON KINE R Y M, LUEGO COMPLETAR INHALOTERAPIA HASTA 7 DIAS
DESDE PUNTO VISTA QXCO (POR DRENAJE HEMATOMA) CURACIONES DIA POR MEDIO Y RETIRO DE PUNTOS A LOS 10 DIAS POST DRENAJE
CONTINUAR TTOS Y CONTROLES CRONICOS

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo relativo asistido | Semisentado Cabecera 30°
2. Regimen hiposódico, hipograso a tolerancia
3. Ceftriaxona 2 gr al dia ev por 3 dias mas
4. Prednisona 20mg 1 al dia vo por 5 dias
5. Bromuro ipratropio 4 puff c/6h Inh x 7 dias
6. Salbutamol 2 puff c/6h Inh x 7 dias
7. Paracetamol 500mg 2 c/8hrs vo sos si dolor o fiebre
8. KNT M y R por 3 dias al menos, reevaluar continuar por equipo kine Hodom
9. Continuar ttos y controles crónicos habituales
10. Curaciones dia por medio
11. Retirar puntos a los 10 dias de drenaje (el 15/05/24)
12. Control aps o urgencias sos
13. Continuar controles por CA prostatico

OMAR ULLOA GUTIERREZ
MEDICO TRATANTE
13102850-4

JEFE SERVICIO